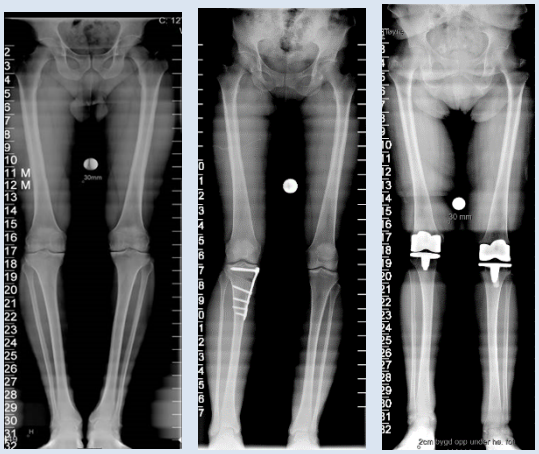
RG Aksemåling underekstremiteter LAB 3 Moss

Endring siden forrige versjon
Nytt dokument.

Indikasjon	Aksemåling	Måling av akser i underekstremiteter	Front (stående) med blykule

Aksemåling Front		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Ofte som preoperativ undersøkelse før kneprotese. Også før og etter osteotomier i tibia ved kneartrose hos yngre pasienter.	
POSISJONERING	Pasienten står barbent, midt i lysfeltet, på det nedfelte fotbrettet på stativet. Strake ben, med lik tyngde på begge føtter, hælene godt bakover. Føttene i nøytral stilling med litt mellomrom og tærne pekende rett fram. Blykule festes på innsiden av det ene låret, i høyde med femurskaftet.	
SENTRERING	Klikk på **S-Guide** for å få frem kameraet. Bruk innblendingsknappene under bildet til å blende ut i bredden. I høyden brukes linjene i bildet til å markere start og stopp i bildetakingen. Pasienten kan gjerne holde fingrene på cristakanten, slik at vi kan finne startposisjonen. Den nederste linjen legges under ankelnivå. Man vil nå se om det blir 2-5 bilder, alt etter pasientens høyde. Når alt er klart lar pasienten armene henge ned, litt ut fra siden. Trykk **Set**, deretter **Apply**, og det er nå klart for eksponering. Rør og bucky stiller seg da inn, og vil flytte seg underveis i bildetakingen. Hold eksponeringsknappen inne til alle bildene er tatt. Det vil komme opp ett og ett bilde, som stitches sammen automatisk. Bildeopptak i en bevegelse ovenfra og ned.	
STRÅLERETNING	0° FFA 200 cm	
BILDEKRITERIER	**Fra nedre kant av ileosacralledd til gjennom ankelledd** Ved indikasjon valgiserende/variserende osteotomier og kontroller skal patella helst være projisert midt over femur. ***Viktigst er at <u>max 1/3-del</u> av caput fibula overprojiseres av tibia.*** Det kan hende man må rotere tærne litt mot hverandre.	
KOMMENTAR	Det er laget eget «program» på apparatet for å finjustere til osteotomibilder (**Osteotomi Lavdose**). Velg «**Baby**» sånn at man får tatt lavdosebilde over begge caput fibulae. Juster til man er fornøyd. Velg så vanlig **Aksemåling,** og endre til **Small/Medium/Large**, og still inn som over. Sjekk om det er bevegelse i bildet før du godkjenner. Noe kan reddes i etterkant, men ved mye bevegelse må bildet tas på nytt. Det er kun den stitchede serien som går over til PACS, og den skal **sendes over 2 ganger**. Om ønskelig er det mulig å få over enkeltbildene også. Kontakt Tone eller June, så kan dette ordnes i etterkant. Det kommer automatisk tekst med **30 mm** på bildene, flytt denne teksten til like over/under blykulen.	

Postprosessering:

Send originalbildene til PACS.

Om du ønsker å gjøre endringer så klikk på ikonet **Extra tools**; (boks med 3 prikker), deretter på ikonet **Stitching**; (boks med 3 firkanter over hverandre med en hånd foran).

Du vil få opp bildene med overlappingen. Hold musepekeren på bildet, og juster bildet. Sideforskyv slik at skjelettet får jevn kontur i corticalis.

På venstre side får du opp bildene enkeltvis, og her kan du klikke på de enkelte bildene og endre svertning/kontrast i de ulike bildene. Klikk på ikonet oppe til høyre med **mørk/lys sol**, og juster til ønsket svertning.

Når du er fornøyd, klikk **Save.**

Send bildene over til PACS, 2 ganger.

Om du får forespørsel i etterkant går du på **Review,** finner pasienten på lista, og velger **Append**. Deretter følger du oppskriften ovenfor.

Referanser

Vedlegg

Andre kilder/litteraturliste

Slutt på Retningslinje